EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 80605
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 13-03-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA TRINIDAD GATICA JIMENEZ			RUN	: 3.827.886-K
F.Nac	: 29-03-1935	Edad	: 88 AÑOS, 11 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: FREIRE 640			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 412072		
Fecha Ingreso	: 2024-03-07	Fecha Egreso	: 13-03-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R56.8-OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Episodio convulsivo
2. Cirugia reciente Hemicolectomia Derecha 23.2.24
a. Tumor de colon ascendente
3. Síndrome Febril autolimitado resuelto.
4. Cardiopatía Coronaria - Stent DA proximal y Med
5. FA crónica En TACO
a. CHADVASC 3 puntos
b. HASBLED 5 puntos (riesgo de sangrado en 1 año 4.9- 19.6%)
6. HTA
7. DM2 NIR
8. Monorrena Quirurgica por TU renal.
9. Ateromatosis aortica
10. DLP
11. ACV antiguos

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. R56-CONVULSIONES NO ESPECIFICADAS EN OTRA PARTE (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I48-FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. E10-E14-DIABETES MALLITUS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina de 89 años con antecedente de hospitalización reciente en febrero 2024 por hemicolectomia en relación a Ca colon. Posterior al alta en buenas condiciones. Es traída por SAMU el 07/03 al servicio de urgencias del HSC por cuadro de compromiso estado general progresivo, cefalea, asociado a sindrome confusional y poliaquiria.
Al ingreso Con FC 115, PA 171/104, T° 38.7°C, Sat 100 y HGT 148. Al examen se describe orientada, sin otra especificación de examen neurológico. Se solicitó TC de cerebro ya que durante traslado en SAMU habría presentado episodio de "rigidez generalizada, desviación de mirada, cianosis y sialorrea" con recuperación ad integrum sin estado postictal. Se administró Lorazepam EV, carga con Levetiracetam 1 gramo y se traslada a reanimación donde se constata FC 150-160 por lo que se administró Lanatósido C. Se realizó estudio de laboratorio sin alteraciones de relevancia y TC de encéfalo en que se constatan lesiones isquémicas seculares frontal lateral derecha, occipitales mesial bilateral, talamicas lacunares bilateral y capsular anterior derecha que de alguna manera podrían producir cuadros convulsivos pero clínica no sigerente de estos. Sin otras complicaciones. Se hospitalizó para tratamiento y evaluación por Neurologia

Se solicitó angioTC de cerebro y cuello el 08/03/24 que no evidencia cambios en parénquima ni alteraciones vasculares de relevancia.
Evaluada por neurólogo Dr. Norambuena el 11/03, quyien describe que cuadro no impresiona claramente de características comiciales y considerando control de signos vitales posterior podría ser explicable por sincope convulsivo cardiogenico en relación a FA RVR versus comicial explicado por lesiones isquémicas antiguas en parénquima que pudieran facilitar el evento, ajustando dosis de levetiraceram. Se revisa en sistema evaluada por cardiología (pre cirugia), donde se evidencia toma de ecocardiograma, sin encontrar examen en sistema.
Paciente alimentada por SNG durante hospitalización, la cual se retira ya que paciente tolera de buena forma la via oral. Además, presenta episodio febril, se estudia con TAC TAP con contraste sin evidencia de procesos infecciosos actuales, con parámetros inflamatorios bajos. Por lo que no se inicia tratamiento ATB.
Actualmente en buenas condiciones generales, asintomática, niega dolores. Sin nuevos episodios convulsivos, por lo que se decide traslado a Hodom debido aun a proceso de rehabilitación motora donde tenia mejor funcionalidad previa a ingreso a nuestro centro. Consultado Neurologo y evaluado el caso se decide anticoagular debido a que presenta aun funcionalidad que permite cierto grado de independencia en algunas actividades.

PLAN DE MANEJO:

Control en CAE neuro con holter
Control poli cirugia
Controles habituales patologias cronicas APS

INDICACIONES AL ALTA

1. 1. Traslado a HODOM para continuar Kinesioterapia motora
2. 2. Reposo relativo asistido
3. 3. Regimen blando hiposodico para diabeticos
4. 4. Levetiracetam 500 mg, 1/2 comp cada 12 horas
5. 5. Sertralina 50 mg, 1 comp al día
6. 6. Aspirina 100 mg, 1 comp al día
7. 7. Atorvastatina 20 mg, 1 comp al día
8. 8. Bisoprolol 2.5 mg cada 12 h VO
9. 9. Losartan 50 mg 1 comp cada 12 horas
10. 10. Metformina 850 mg, 1 comp al día
11. 11. Apixaban 2.5 mg cada 12 h VO
12. 12. Control en poli cirugía con biopsia (según lo indicado por dicha especialidad).
13. 13. Holter de ritmo (realizar ambulatorio);
14. 14. Control patologías crónicas en poli medicina interna en 3 semanas
15. 15. Control en CAE con neurólogo 1 mes post alta (con holter)
16. 16. En caso de signos de alarma: fiebre que no cede a antipiréticos, sangrados, compromiso de conciencia, habla traposa, convulsiones, consultar en servicio de urgencias

OBSERVACIONES:

Interna Maria Jose Cartes
Dr Jorge Villa Flores

Jorge Andres Villa Flores
MEDICO TRATANTE
16178692-6

JEFE SERVICIO